MEDINA · CYCLE 1 · DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE

Le travail en images

I63 · E11 · N17 · D50

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE

Captures réelles du plan, de l’accueil et de quatre copies de cours.

Les brouillons montrés ne sont pas injectés. Aucun contenu de ce dossier n’est présenté comme validé médicalement.

Photographie indépendante : C01-PHOTO · 11.10.2026 à 19:58:40 UTC+02:00 · Europe/Zurich
28 captures dans le PDF · une image entière par page · Atkinson Hyperlegible Next
Ordinateur : 1440 px · mobile : 390 px · densité de capture : × 2

Plan de progression · 30 cycles

11.10.2026 à 19:48:15 UTC+02:00 · Europe/Zurich

INSTRUCTION DU DR VIAL · 11 OCTOBRE 2026 · VERSION 1

Progression lente de la tétrade

Neurologie · Endocrinologie et métabolisme · Néphrologie · Hématologie

Un chapitre par agent. Un audit croisé par binôme. Un contre-audit par agents différés. Un contrôle final par Codex. Une injection à la fois.

30	120	2	270
cycles strictement successifs	missions · quatre par cycle	brouillons existants à reprendre	catégories CIM inventoriées

Barrière obligatoire de 0,5 cm. Aucun cycle suivant ne commence sans clôture du précédent et respect du Prompt de vérité.

Périmètre confirmé par la pièce jointe de Vial : Neurologie, Endocrinologie et métabolisme, Néphrologie, Hématologie. L'inventaire du dépôt confirme les 116, 77, 33 et 44 catégories affichées dans l'image.

INVENTAIRE GELÉ AU 11 OCTOBRE 2026

Ce que les 30 cycles traitent réellement

Les quatre systèmes ne possèdent aucun cours intégré à cette date. Les 120 missions portent sur 120 catégories distinctes, trente par système. Deux brouillons Claude existent déjà : E11, diabète de type 2, et D50, anémie par carence en fer. Ils seront repris et audités ; ils ne seront pas réécrits sans lecture de leur contenu.

Système	Catégories CIM	Leçons présentes	Catégories vides programmées	Reprises de cours intégrés	Projection de présence	Projection fédérale
Neurologie	116	0 / 116	30	0	30 / 116	29 / 104

CAPTURE 02 / 28 · Section intégrale du plan public

Cycle 1 · quatre attributions et barrière

11.10.2026 à 19:52:29 UTC+02:00 · Europe/Zurich

CYCLE 01 / 30 · QUATRE CHAPITRES · UN AUTEUR PAR CHAPITRE

Cycle 1 : Commencer par les fondements majeurs

Préparation accessible · le cycle peut être ouvert.

☐ Le Prompt est relu ; l'inventaire, les doublons, les sources à lire et les gardes opérationnelles sont vérifiés avant ouverture.

Système : N-05-Neurologie Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : I63 — Infarctus cérébral

☐ Chapitre : Infarctus cérébral

L'auteur distingue les mécanismes et territoires de l'infarctus cérébral, documente les examens, les traitements et la prévention secondaire.

Auteur : C01-R-NEUR · **Audit croisé :** C01-R-HEM · **Contre-audit différé :** C01-CA-NEUR
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de neurologie / Société cérébrovasculaire suisse ; European Stroke Organisation ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : I63. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique. Ouvrir la catégorie MEDINA.

- ☐ Sources et périmètre
- ☐ Audit croisé · passe 1
- ☐ Contre-audit · passe 1
- ☐ Contrôle final Codex
- ☐ Rédaction complète
- ☐ Audit croisé · passe 2
- ☐ Contre-audit · passe 2

Preuves : sources, deux audits, contre-audit, empreinte finale, commit et URL publiée

Références vérifiables du dossier de preuves — nécessaires avant le contrôle final.

Système : E-06-Endocrinologie et métabolisme

Reprise du brouillon existant

Catégorie : E11 — Diabète sucré, type 2

☐ Chapitre : Diabète sucré, type 2

L'auteur reprend le brouillon Claude existant, vérifie les complications et les produits suisses, puis le soumet à la nouvelle chaîne complète d'audits.

Auteur : C01-R-ENDO · **Audit croisé :** C01-R-NEPH · **Contre-audit différé :** C01-CA-ENDO
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'endocrinologie et de diabétologie / Swiss Medical Forum ; ESE, EASD et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : E11. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

- ☐ Sources et périmètre
- ☐ Audit croisé · passe 1
- ☐ Contre-audit · passe 1
- ☐ Contrôle final Codex
- ☐ Rédaction complète
- ☐ Audit croisé · passe 2
- ☐ Contre-audit · passe 2

Preuves : sources, deux audits, contre-audit, empreinte finale, commit et URL publiée

Références vérifiables du dossier de preuves — nécessaires avant le contrôle final.

Système : N-07-Néphrologie Production nouvelle · inventaire préalable

Catégorie : N17 — Insuffisance rénale aiguë

☐ Chapitre : Insuffisance rénale aiguë

L'auteur traite l'insuffisance rénale aiguë, les causes, les critères et les indications des mesures de soutien ou de recours spécialisé.

Auteur : C01-R-NEPH · **Audit croisé :** C01-R-ENDO · **Contre-audit différé :** C01-CA-NEPH
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse de néphrologie / Swiss Medical Forum ; ERA et KDIGO applicables en Suisse ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : N17. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

- ☐ Sources et périmètre
- ☐ Audit croisé · passe 1
- ☐ Contre-audit · passe 1
- ☐ Contrôle final Codex
- ☐ Rédaction complète
- ☐ Audit croisé · passe 2
- ☐ Contre-audit · passe 2

Preuves : sources, deux audits, contre-audit, empreinte finale, commit et URL publiée

Références vérifiables du dossier de preuves — nécessaires avant le contrôle final.

Système : H-08-Hématologie Reprise du brouillon existant

Catégorie : D50 — Anémie par carence en fer

☐ Chapitre : Anémie par carence en fer

L'auteur reprend le brouillon Claude existant, vérifie les explorations et les formes suisses du fer, puis suit la nouvelle chaîne complète d'audits.

Auteur : C01-R-HEM · **Audit croisé :** C01-R-NEUR · **Contre-audit différé :** C01-CA-HEM
Contrôle et injection : Codex — coordinateur du fil.

Sources à rechercher et à lire : Société suisse d'hématologie / Swiss Medical Forum ; EHA, ESMO et référence européenne adaptée ; FI Swissmedic.

Périmètre actuel : D50. **Repérage :** Étoile fédérale pédagogique ; sélection fréquente. Ouvrir la catégorie MEDINA.

- ☐ Sources et périmètre
- ☐ Audit croisé · passe 1
- ☐ Contre-audit · passe 1
- ☐ Contrôle final Codex
- ☐ Rédaction complète
- ☐ Audit croisé · passe 2
- ☐ Contre-audit · passe 2

Preuves : sources, deux audits, contre-audit, empreinte finale, commit et URL publiée

Références vérifiables du dossier de preuves — nécessaires avant le contrôle final.

Conditions de passage du cycle 1

La case près du titre signifie « injection publiée et vérifiée ». Les quatre injections suivent l'ordre NEUR → ENDO → NEPH → HEM. Les cases ci-dessous ne sont accessibles qu'après ces quatre injections.

- ☐ Toutes les réserves bloquantes sont closes ; les rapports portent sur les empreintes finales.
- ☐ Les deux captures réelles de chaque leçon sont conservées ; ordinateur et mobile sont contrôlés.
- ☐ Les quatre injections successives sont accessibles ; les jauges et renvois sont vérifiés.
- ☐ Le coordinateur a signé le reçu de cycle et la décision de passage, avec preuves et SHA.

PASSAGE VERS LE CYCLE 2 INTERDIT SANS CLÔTURE ET PROMPT DE VÉRITÉ

Planification publique ; pas un audit ni une preuve d'achèvement.

Source : plan public MEDINA
PNG : 04-cycle1-plan-integral.png · SHA-256 : 94ddfd9260def88a4f95… · empreinte complète dans manifest.json

CAPTURE 03 / 28 · Ordinateur · ouverture de l’accueil

Accueil MEDINA · jauges

11.10.2026 à 19:57:54 UTC+02:00 · Europe/Zurich



Préparation technique locale. Jauges de présence, aucune validation médicale. Les quatre cours du cycle 1 ne sont pas injectés.

Source : accueil de préparation locale · index après correction des contours
PNG : 03-accueil-local-desktop.png · SHA-256 : 717d6b7236a3f520f98d… · empreinte complète dans manifest.json

CAPTURE 04 / 28 · Rangée réelle de quatre cartes · contours corrigés

Les quatre spécialités du cycle 1

11.10.2026 à 19:57:57 UTC+02:00 · Europe/Zurich

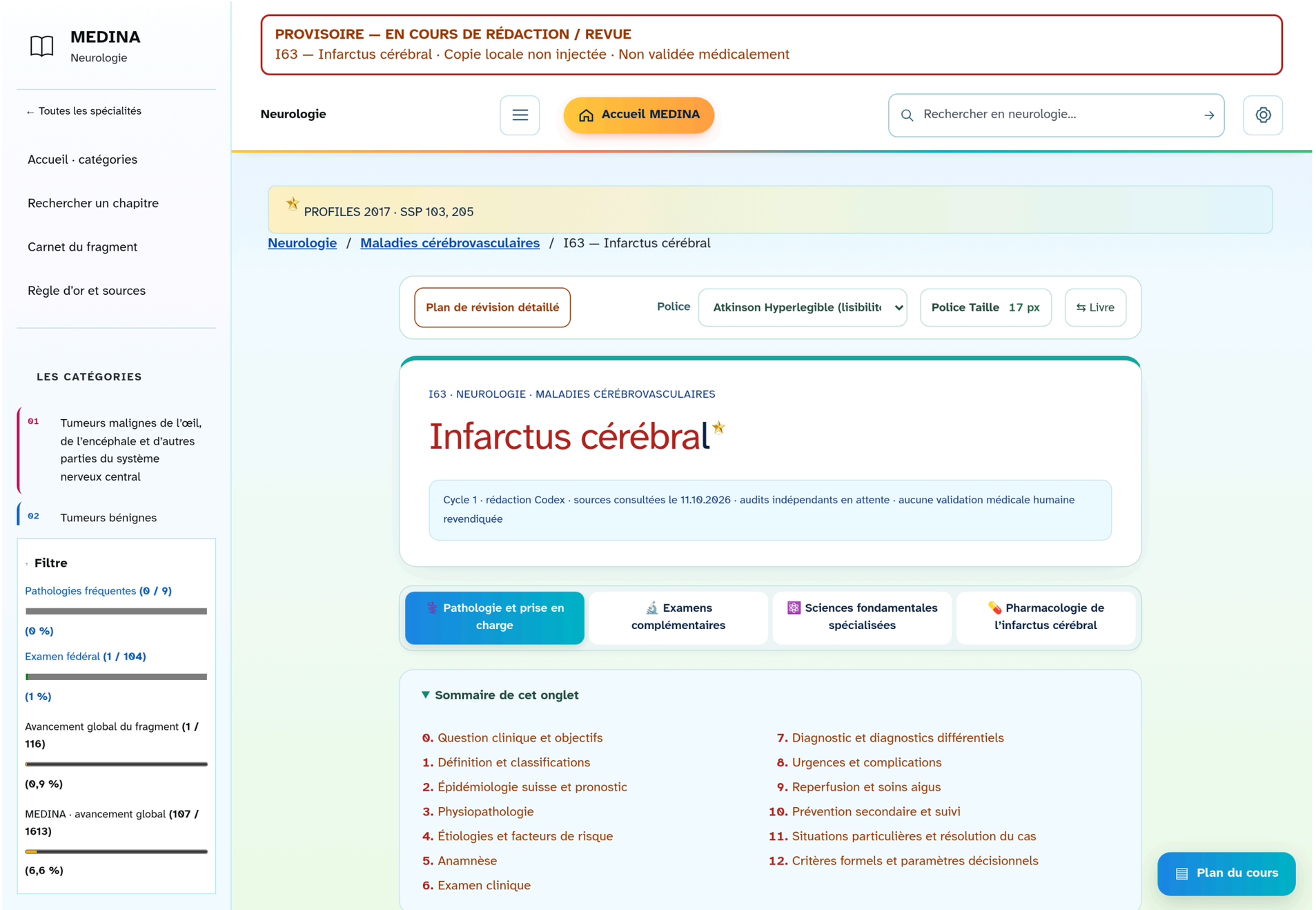


Préparation technique locale. Jauges de présence, aucune validation médicale. Les quatre cours du cycle 1 ne sont pas injectés.

Source : accueil de préparation locale · index après correction des contours
PNG : 07-accueil-quatre-cartes.png · SHA-256 : 99f59152237224ad1b9e… · empreinte complète dans manifest.json

I63 — Infarctus cérébral

11.10.2026 à 19:54:46 UTC+02:00 · Europe/Zurich



PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de I63 · 11.10.2026 à 19:53:27 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : I63-01-pathologie-desktop.png · SHA-256 : 740d331356934d65c66b… · empreinte complète dans manifest.json

I63 — Infarctus cérébral

11.10.2026 à 19:54:47 UTC+02:00 · Europe/Zurich



CAPTURE 07 / 28 · Ordinateur · fenêtre explicative ouverte

I63 — Infarctus cérébral

11.10.2026 à 19:54:47 UTC+02:00 · Europe/Zurich



PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de I63 · 11.10.2026 à 19:53:27 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : I63-03-fenetre.png · SHA-256 : 62599b6567531b9f50c2… · empreinte complète dans manifest.json

I63 — Infarctus cérébral

11.10.2026 à 19:54:49 UTC+02:00 · Europe/Zurich

MEDINA
Neurologie

← Toutes les spécialités

Accueil · catégories

Rechercher un chapitre

Carnet du fragment

Règle d'or et sources

LES CATÉGORIES

01 Tumeurs malignes de l'œil, de l'encéphale et d'autres parties du système nerveux central

02 Tumeurs bénignes

Filtre

Pathologies fréquentes **(0 / 9)**

(0 %)

Examen fédéral **(1 / 104)**

(1 %)

Avancement global du fragment **(1 / 116)**

(0,9 %)

MEDINA · avancement global **(107 / 1613)**

(6,6 %)

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
I63 — Infarctus cérébral · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

Neurologie | **Accueil MEDINA** | Rechercher en neurologie...

Cycle 1 · rédaction Codex · sources consultées le 11.10.2026 · audits indépendants en attente · aucune validation médicale humaine revendiquée

Pathologie et prise en charge | Examens complémentaires | Sciences fondamentales spécialisées | Pharmacologie de l'infarctus cérébral

Anatomie vasculaire et fonctionnelle | Physiologie et perfusion | Histologie et biologie cellulaire | Biochimie et hémostase | Génétique et maladies rares

Anatomie vasculaire et fonctionnelle

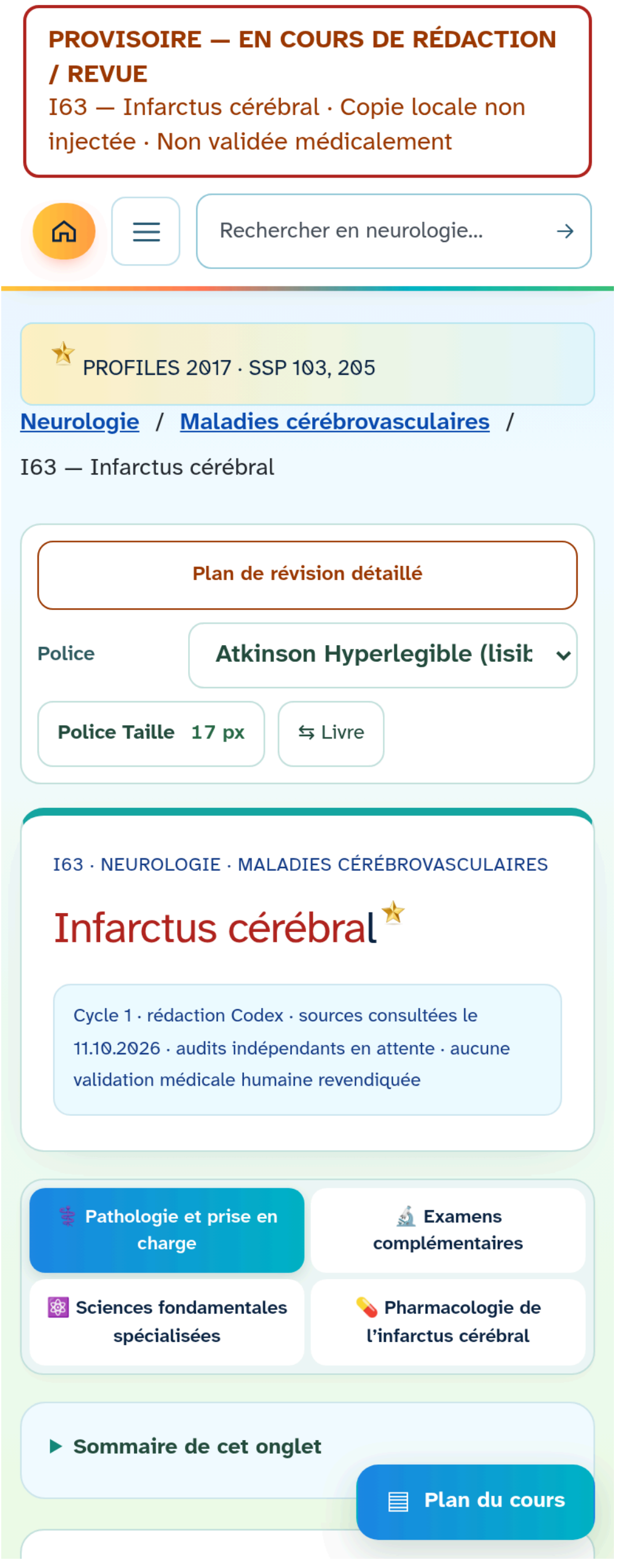
La circulation carotidienne interne contribue aux artères cérébrales antérieures et moyennes. Les deux artères vertébrales rejoignent le système basilaire ; les artères cérébrales postérieures participent au territoire occipital et profond. Les communications à la base du cerveau et les variantes anatomiques expliquent qu'une carte de territoire soit une orientation, non une preuve isolée de l'artère responsable.

Les figures du réseau bernois distinguent territoires corticaux et profonds, ainsi que régions motrices, du langage, visuelles et sensitives. Une aphasie oriente un réseau du langage ; une anomalie du champ visuel oriente les voies visuelles ; l'examen de la motricité, de l'attention et de la coordination complète cette localisation. Les lésions peuvent dépasser une fonction unique et l'examen doit rester global.

Plan du cours

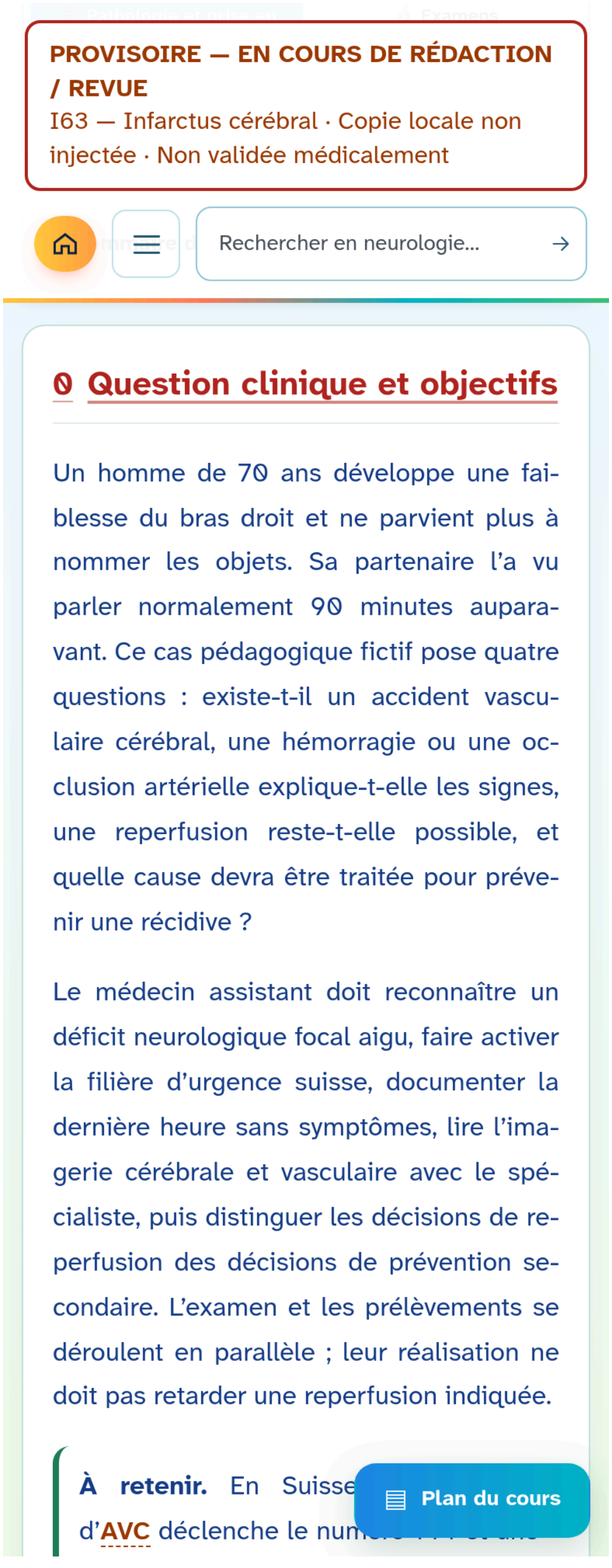
I63 — Infarctus cérébral

11.10.2026 à 19:54:50 UTC+02:00 · Europe/Zurich



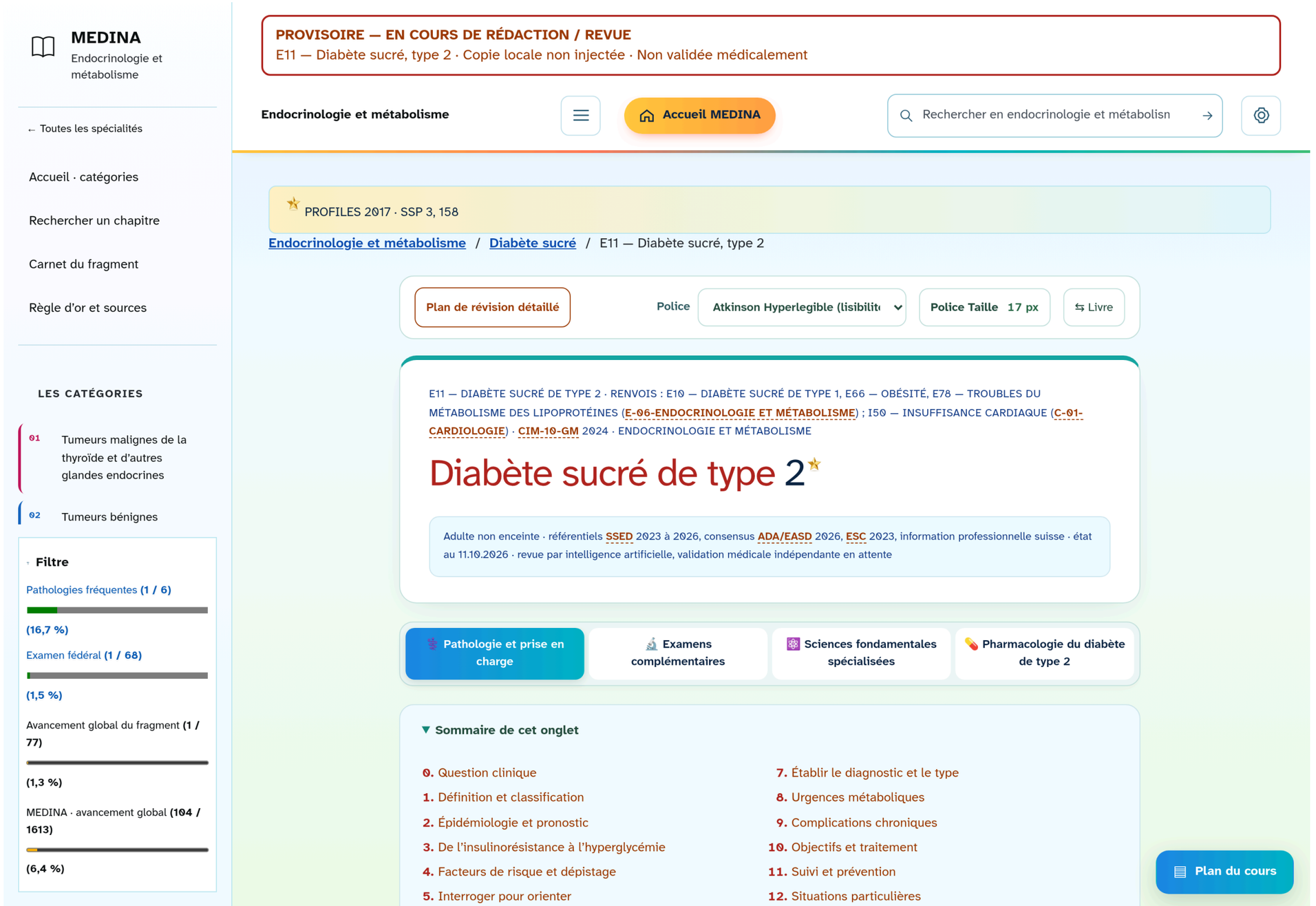
I63 — Infarctus cérébral

11.10.2026 à 19:54:51 UTC+02:00 · Europe/Zurich



E11 — Diabète sucré, type 2

11.10.2026 à 19:54:52 UTC+02:00 · Europe/Zurich



PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de E11 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : E11-01-pathologie-desktop.png · SHA-256 : 5a2b702700e0ebb719e6… · empreinte complète dans manifest.json

E11 — Diabète sucré, type 2

11.10.2026 à 19:54:53 UTC+02:00 · Europe/Zurich

MEDINA
Endocrinologie et métabolisme

← Toutes les spécialités

Accueil · catégories

Rechercher un chapitre

Carnet du fragment

Règle d'or et sources

LES CATÉGORIES

01 Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines

02 Tumeurs bénignes

Filtre

Pathologies fréquentes **(1 / 6)**

(16,7 %)

Examen fédéral **(1 / 68)**

(1,5 %)

Avancement global du fragment **(1 / 77)**

(1,3 %)

MEDINA · avancement global **(104 / 1613)**

(6,4 %)

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
E11 — Diabète sucré, type 2 · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

Endocrinologie et métabolisme · **Accueil MEDINA** · Rechercher en endocrinologie et métabolisn

Pathologie et prise en charge | **Examens complémentaires** | **Sciences fondamentales spécialisées** | **Pharmacologie du diabète de type 2**

Sommaire de cet onglet

0. Question clinique
1. Définition et classification
2. Épidémiologie et pronostic
3. De l'insulinorésistance à l'hyperglycémie
4. Facteurs de risque et dépistage
5. Interroger pour orienter
6. Examiner pour mesurer le retentissement
7. Établir le diagnostic et le type
8. Urgences métaboliques
9. Complications chroniques
10. Objectifs et traitement
11. Suivi et prévention
12. Situations particulières
13. Critères formels et paramètres clés

0 Question clinique

Un homme de 58 ans, chauffeur-livreur, consulte pour un bilan de santé. Il ne se plaint de rien. Son indice de masse corporelle (IMC) atteint 32 kg/m² et sa pression artérielle 146/88 mmHg. La glycémie veineuse à jeun mesure 8,4 mmol/L ; deux semaines plus tard, l'HbA1c vaut 8,1 %. Le rapport albumine/créatinine urinaire est de 6 mg/mmol et le débit de filtration glomérulaire (DFG) estimé de 68 mL/min/1,73 m².

Quatre questions structurent la consultation. Le diagnostic est-il établi, et s'agit-il bien d'un diabète de type 2 ? Quels organes sont déjà menacés, et quel est le risque cardiovasculaire et rénal ? Quels médicaments réduisent ce risque au-delà de la glycémie ? Ce traitement est-il compatible avec la conduite professionnelle ?

Plan du cours

E11 — Diabète sucré, type 2

11.10.2026 à 19:54:53 UTC+02:00 · Europe/Zurich



E11 — Diabète sucré, type 2

11.10.2026 à 19:54:55 UTC+02:00 · Europe/Zurich

MEDINA
Endocrinologie et métabolisme

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
E11 — Diabète sucré, type 2 · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

Endocrinologie et métabolisme

Accueil MEDINA

Rechercher en endocrinologie et métabolisn

← Toutes les spécialités

Accueil · catégories

Rechercher un chapitre

Carnet du fragment

Règle d'or et sources

LES CATÉGORIES

01 Tumeurs malignes de la thyroïde et d'autres glandes endocrines

02 Tumeurs bénignes

Filtre

Pathologies fréquentes **(1 / 6)**

(16,7 %)

Examen fédéral **(1 / 68)**

(1,5 %)

Avancement global du fragment **(1 / 77)**

(1,3 %)

MEDINA · avancement global **(104 / 1613)**

(6,4 %)

Diabète sucré de type 2

Adulte non enceinte · référentiels SSED 2023 à 2026, consensus ADA/EASD 2026, ESC 2023, information professionnelle suisse · état au 11.10.2026 · revue par intelligence artificielle, validation médicale indépendante en attente

Pathologie et prise en charge | Examens complémentaires | Sciences fondamentales spécialisées | Pharmacologie du diabète de type 2

Biologie cellulaire | Physiologie | Biochimie | Physiologie rénale

Biologie cellulaire : la cellule β et sa défaillance

Pourquoi la cellule β, capable de sécréter davantage pendant des années, finit-elle par céder ? La réponse tient à la manière dont elle couple le glucose à la sécrétion d'insuline, et à la fragilité de ce couplage face à l'excès de nutriments.

Du glucose à l'exocytose

L'insuline est synthétisée sous forme de pré-proinsuline. Dans le réticulum endoplasmique, elle devient proinsuline, puis l'appareil de Golgi la clive en insuline et en peptide C, stockés ensemble dans des granules. Quand la glycémie monte, le glucose entre dans la cellule par le transporteur transporteurs du glucose, qui sert aussi de capteur. Son métabolisme élève le rapport ATP/ADP, ce qui ferme les canaux potassiques sensibles à l'ATP. La membrane se dépolarise, des canaux calciques voltage-dépendants s'ouvrent et l'entrée de Ca^{2+} déclenche l'exocytose des granules. L'AMPc amplifie cette sécrétion ; c'est par lui que les agonistes du récepteur du GLP-1 renforcent la réponse au glucose.

Plan du cours

E11 — Diabète sucré, type 2

11.10.2026 à 19:54:56 UTC+02:00 · Europe/Zurich



E11 — Diabète sucré, type 2

11.10.2026 à 19:54:57 UTC+02:00 · Europe/Zurich

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
E11 — Diabète sucré, type 2 · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

Rechercher en endocrinologi

0 Question clinique

Un homme de 58 ans, chauffeur-livreur, consulte pour un bilan de santé. Il ne se plaint de rien. Son indice de masse corporelle (**IMC**) atteint 32 kg/m² et sa pression artérielle 146/88 mmHg. La glycémie veineuse à jeun mesure 8,4 mmol/L ; deux semaines plus tard, l'**HbA1c** vaut 8,1 %. Le rapport albumine/créatinine urinaire est de 6 mg/mmol et le débit de filtration glomérulaire (**DFG**) estimé de 68 mL/min/1,73 m².

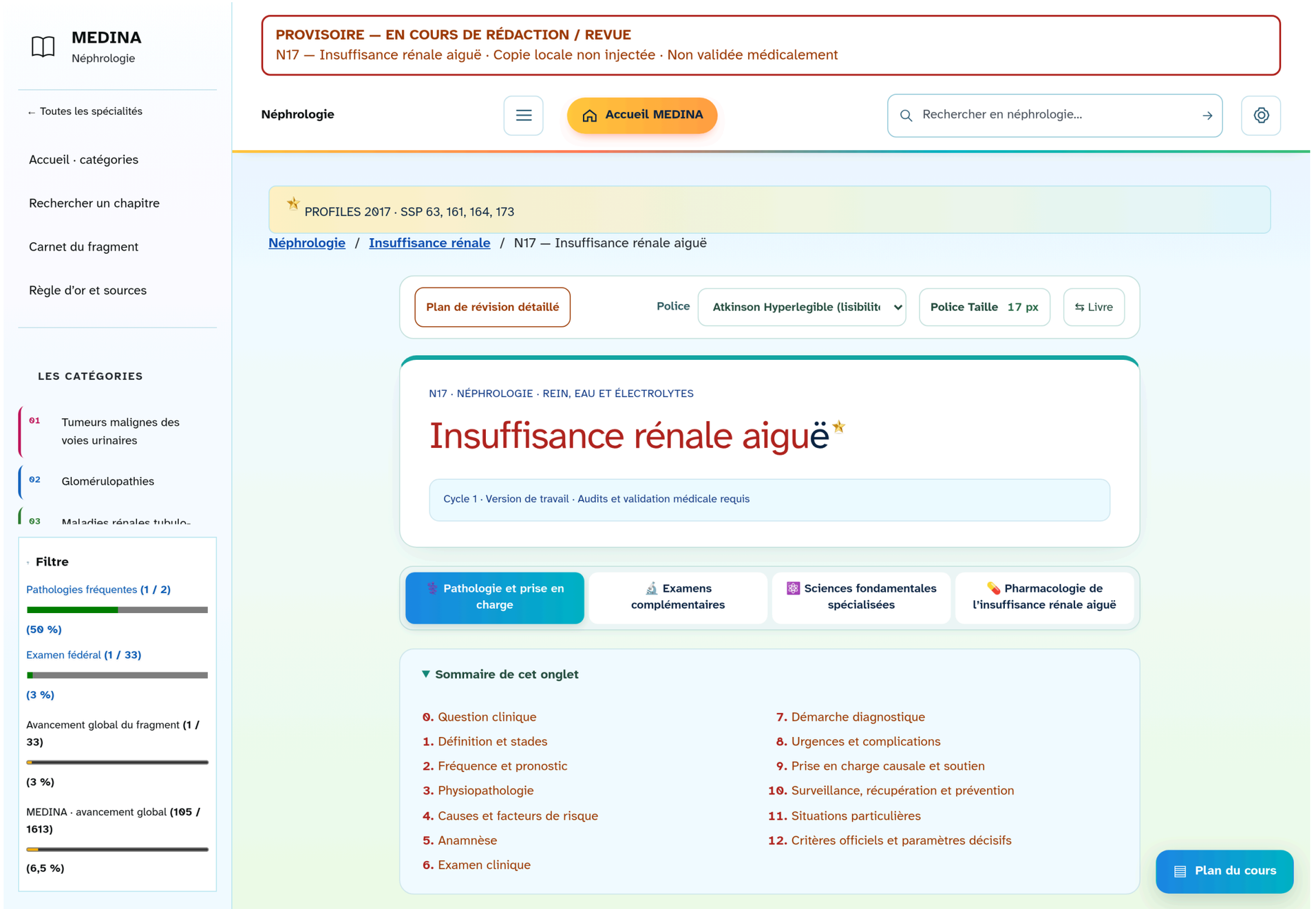
Quatre questions structurent la consultation. Le diagnostic est-il établi, et s'agit-il bien d'un diabète de type 2 ? Quels organes sont déjà menacés, et quel est le risque cardiovasculaire et rénal ? Quels médicaments réduisent ce risque au-delà de la glycémie ? Ce traitement est-il compatible avec la conduite professionnelle ?

> **Point de départ.** Un diabète de type 2 se découvre souvent sans symptôme, par une mesure de rou
> **ment moderne ne vis**

Plan du cours

N17 — Insuffisance rénale aiguë

11.10.2026 à 19:54:58 UTC+02:00 · Europe/Zurich



N17 — Insuffisance rénale aiguë

11.10.2026 à 19:54:59 UTC+02:00 · Europe/Zurich

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
N17 — Insuffisance rénale aiguë · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

Cycle 1 · Version de travail · Audits et validation médicale requis

▼ Sommaire de cet onglet

0. Question clinique
1. Définition et stades
2. Fréquence et pronostic
3. Physiopathologie
4. Causes et facteurs de risque
5. Anamnèse
6. Examen clinique
7. Démarche diagnostique
8. Urgences et complications
9. Prise en charge causale et soutien
10. Surveillance, récupération et prévention
11. Situations particulières
12. Critères officiels et paramètres décisifs

0 Question clinique

Un homme de 70 kg arrive après des pertes digestives. Sa créatinine est passée de 80 à 210 µmol/L en 48 heures. Sa diurèse vaut 0,35 mL/kg/heure depuis 14 heures, et sa kaliémie atteint 6,8 mmol/L. Ce cas pédagogique pose trois questions : **quelle est la gravité, quelle cause domine et quelle complication doit être traitée immédiatement ?**

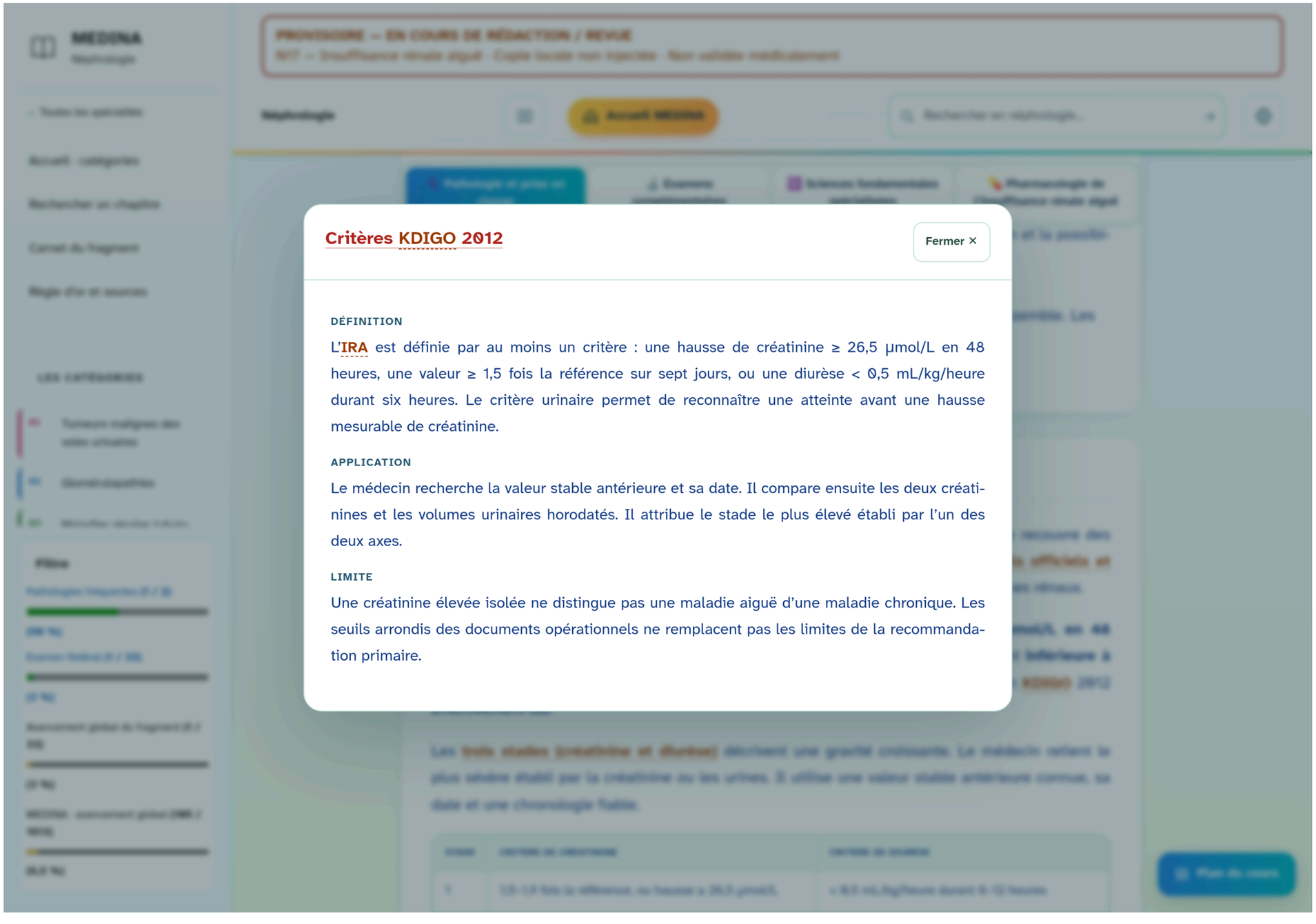
La kaliémie impose une évaluation urgente avant la fin du bilan causal. La créatinine et la diurèse établissent chacune un stade 2. Les pertes rendent une hypovolémie plausible, mais ne prouvent pas qu'un remplissage est encore approprié. Le médecin examine aussi la congestion et la possibilité d'obstruction.

Plan du cours

CAPTURE 19 / 28 · Ordinateur · fenêtre explicative ouverte

N17 — Insuffisance rénale aiguë

11.10.2026 à 19:54:59 UTC+02:00 · Europe/Zurich



PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de N17 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : N17-03-fenetre.png · SHA-256 : f3066ffa2d6bb67fc1fb… · empreinte complète dans manifest.json

N17 — Insuffisance rénale aiguë

11.10.2026 à 19:55:01 UTC+02:00 · Europe/Zurich

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
N17 — Insuffisance rénale aiguë · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

N17 · NÉPHROLOGIE · REIN, EAU ET ÉLECTROLYTES

Insuffisance rénale aiguë

Cycle 1 · Version de travail · Audits et validation médicale requis

Pathologie et prise en charge | Examens complémentaires | Sciences fondamentales spécialisées | Pharmacologie de l'insuffisance rénale aiguë

Anatomie | Histologie | Physiologie | Biochimie

Anatomie de l'insuffisance rénale aiguë

La localisation d'une atteinte explique pourquoi les mêmes résultats biologiques conduisent à des gestes différents. Le glomérule filtre vers le tubule ; les voies excrétrices assurent la sortie. La pression de filtration dépend notamment des pressions du capillaire et de la capsule glomérulaire.

La circulation afférente apporte le sang au glomérule, puis la circulation efférente l'en éloigne. Un débit insuffisant réduit la filtration ; un obstacle augmente la pression en aval. Dans le cortex, une destruction ischémique peut atteindre de nombreux tubules, alors qu'une papille nécrosée peut contribuer à un obstacle urétéral.

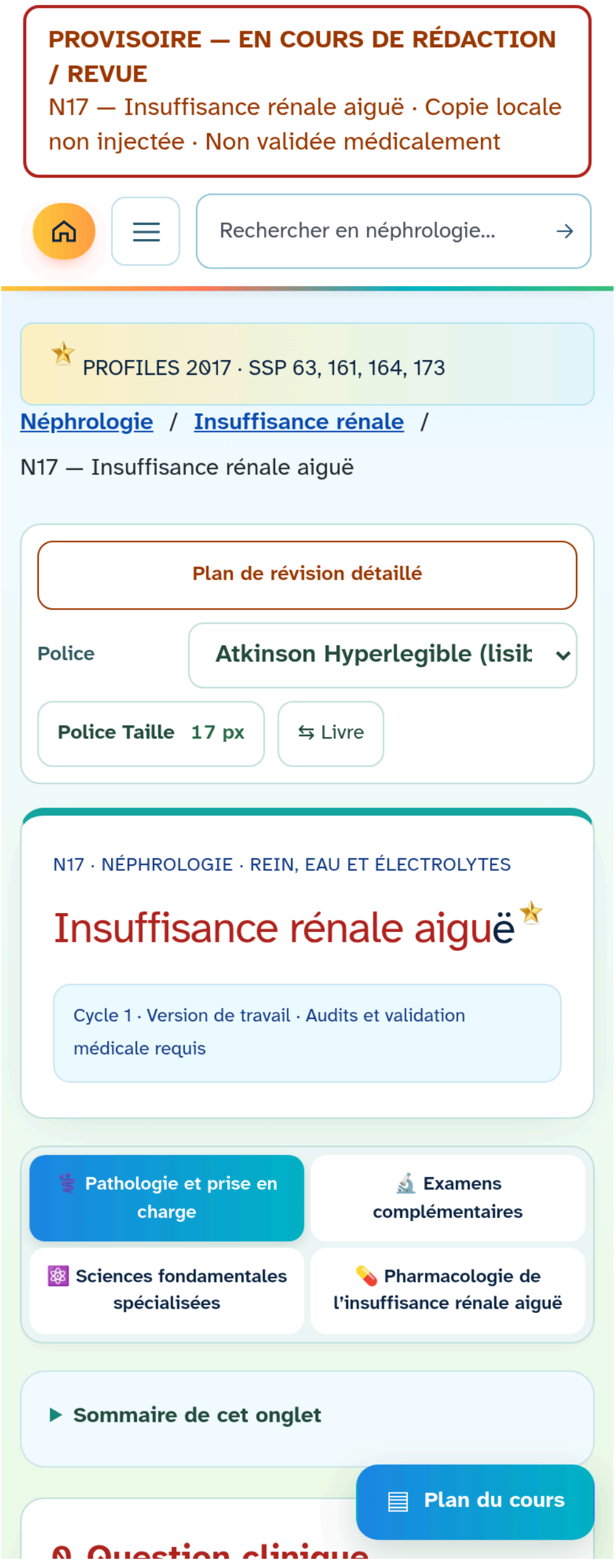
Le schéma distingue le parcours du filtrat et la pression qui peut s'opposer à son départ. Il ne représente pas un néphron à l'échelle et ne chiffre pas une pression individuelle.

PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de N17 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : N17-04-sciences.png · SHA-256 : 7037e3c2ca7993b34e32… · empreinte complète dans manifest.json

N17 — Insuffisance rénale aiguë

11.10.2026 à 19:55:02 UTC+02:00 · Europe/Zurich

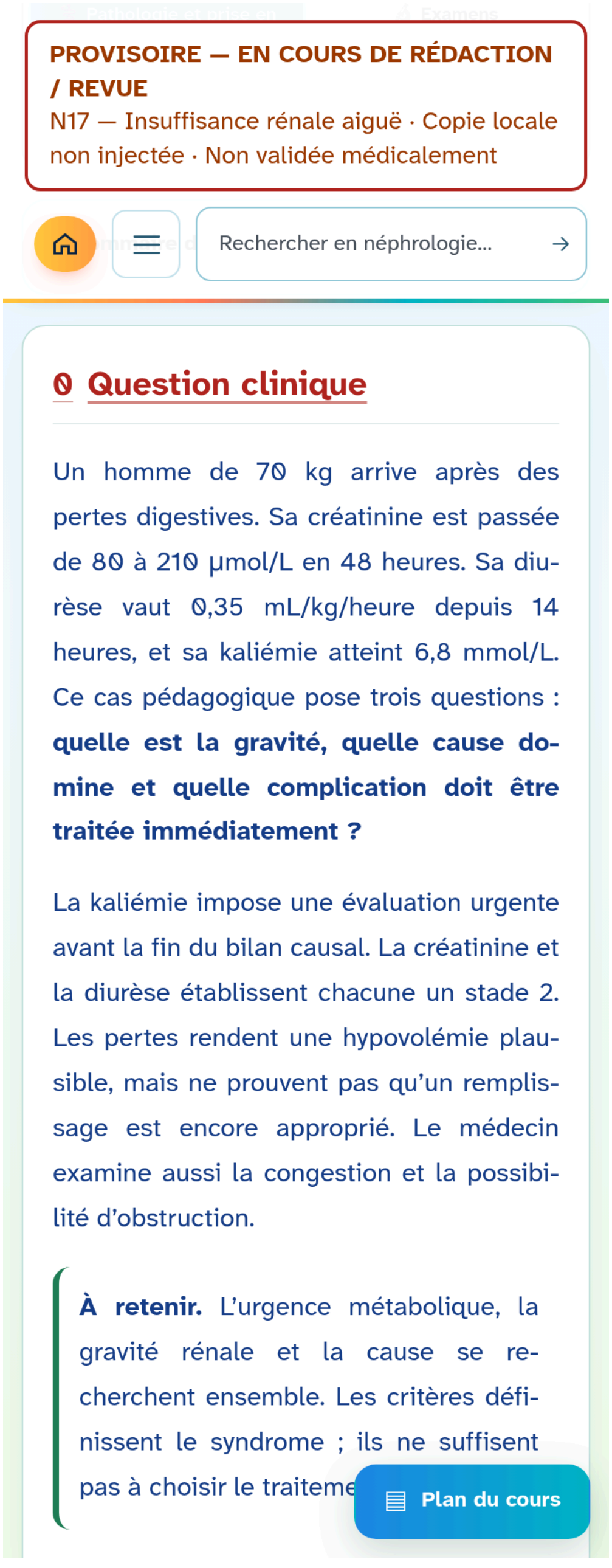


PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de N17 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : N17-05-mobile-ouverture.png · SHA-256 : 9d8fd12cfa95da8fbdce… · empreinte complète dans manifest.json

N17 — Insuffisance rénale aiguë

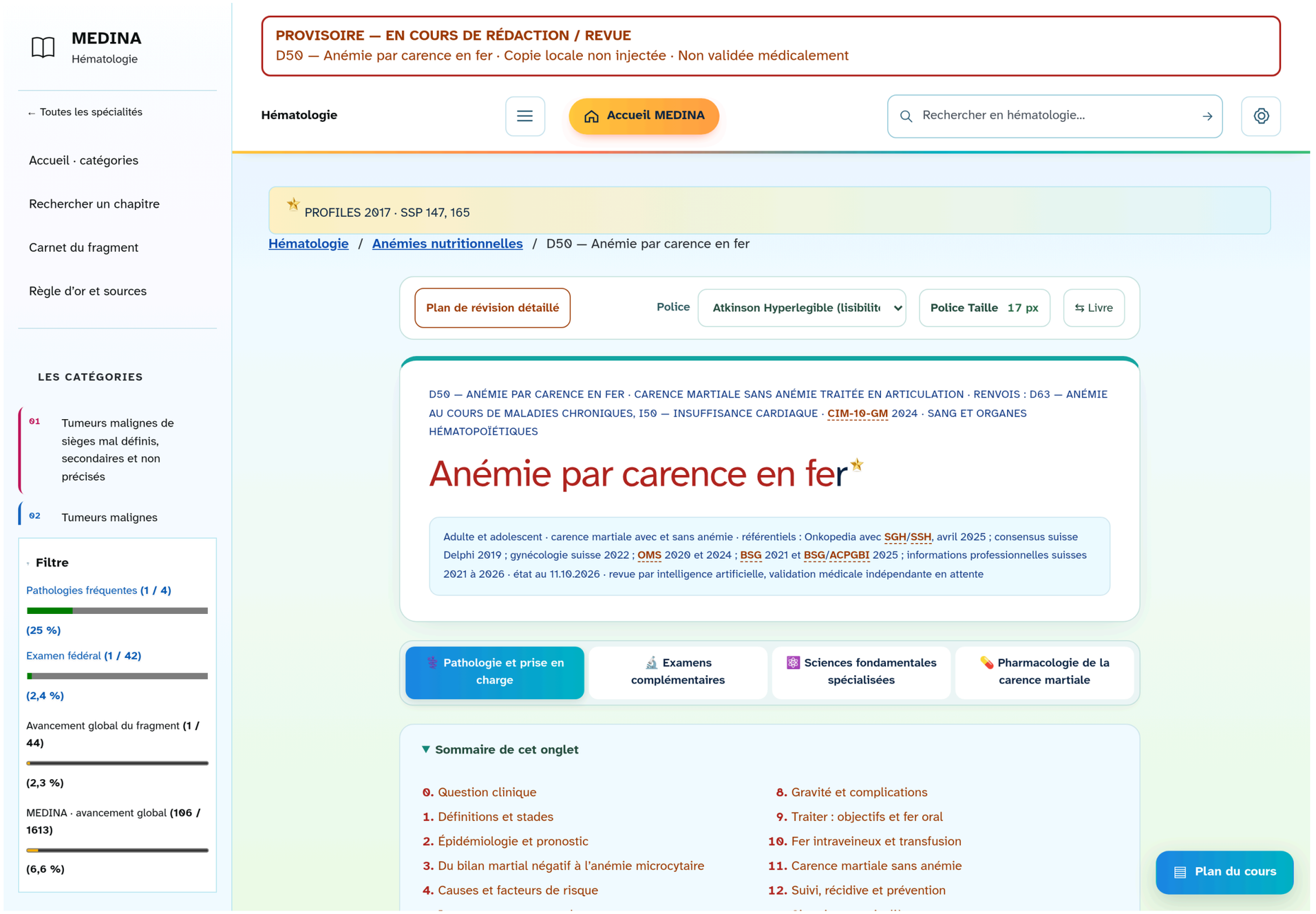
11.10.2026 à 19:55:03 UTC+02:00 · Europe/Zurich



Source : copie figée de N17 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : N17-06-mobile-lecture.png · SHA-256 : b472e543490f97666196… · empreinte complète dans manifest.json

D50 — Anémie par carence en fer

11.10.2026 à 19:55:04 UTC+02:00 · Europe/Zurich

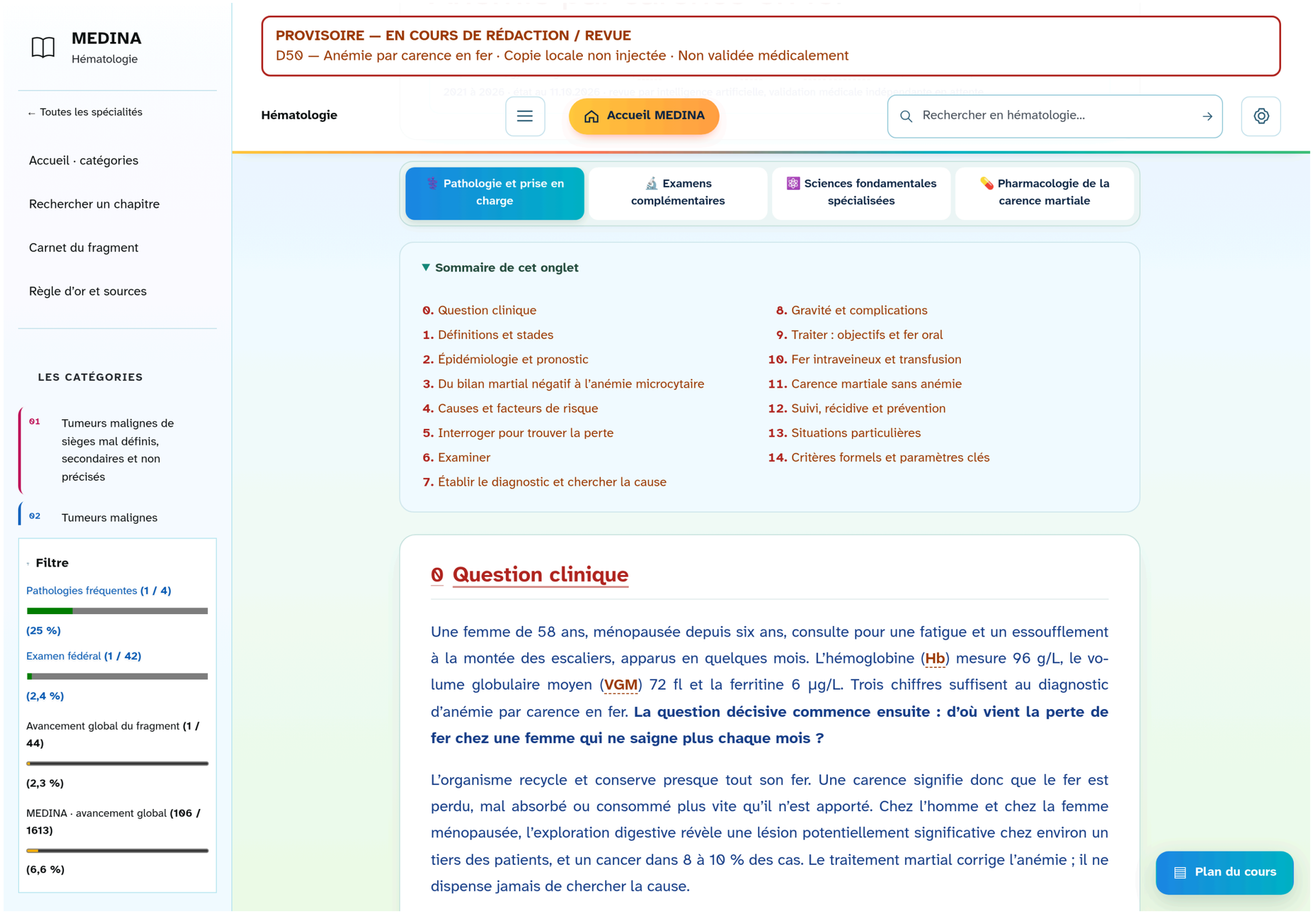


PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de D50 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : D50-01-pathologie-desktop.png · SHA-256 : 1b6d80a3a9dd36943395… · empreinte complète dans manifest.json

D50 — Anémie par carence en fer

11.10.2026 à 19:55:05 UTC+02:00 · Europe/Zurich



D50 — Anémie par carence en fer

11.10.2026 à 19:55:05 UTC+02:00 · Europe/Zurich



PROVISOIRE · copie locale non injectée · non validée médicalement

Source : copie figée de D50 · 11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich
Jauges locales : les brouillons rendus sont comptés dans cet aperçu ; ces valeurs ne prouvent aucune injection et ne sont pas les jauges du site publié.
PNG : D50-03-fenetre.png · SHA-256 : 25ef7a6eb03fcb68038d… · empreinte complète dans manifest.json

D50 — Anémie par carence en fer

11.10.2026 à 19:55:06 UTC+02:00 · Europe/Zurich

MEDINA
Hématologie

PROVISOIRE — EN COURS DE RÉDACTION / REVUE
D50 — Anémie par carence en fer · Copie locale non injectée · Non validée médicalement

Hématologie

Accueil MEDINA

Rechercher en hématologie...

← Toutes les spécialités

Accueil · catégories

Rechercher un chapitre

Carnet du fragment

Règle d'or et sources

LES CATÉGORIES

01 Tumeurs malignes de sièges mal définis, secondaires et non précisés

02 Tumeurs malignes

Filtre

Pathologies fréquentes **(1 / 4)**

(25 %)

Examen fédéral **(1 / 42)**

(2,4 %)

Avancement global du fragment **(1 / 44)**

(2,3 %)

MEDINA · avancement global **(106 / 1613)**

(6,6 %)

Anémie par carence en fer

Adulte et adolescent · carence martiale avec et sans anémie · référentiels : Onkopedia avec SGH/SSH, avril 2025 ; consensus suisse Delphi 2019 ; gynécologie suisse 2022 ; OMS 2020 et 2024 ; BSG 2021 et BSG/ACPGBI 2025 ; informations professionnelles suisses 2021 à 2026 · état au 11.10.2026 · revue par intelligence artificielle, validation médicale indépendante en attente

Pathologie et prise en charge | Examens complémentaires | Sciences fondamentales spécialisées | Pharmacologie de la carence martiale

Physiologie | Biochimie | Hématologie cellulaire | Génétique

Physiologie : absorption, recyclage et régulation

Pourquoi un saignement occulte de quelques millilitres par jour suffit-il à créer une anémie, alors que l'intestin peut augmenter son absorption ? La réponse tient à une particularité : l'organisme règle son fer uniquement à l'entrée, jamais à la sortie.

Le circuit normal

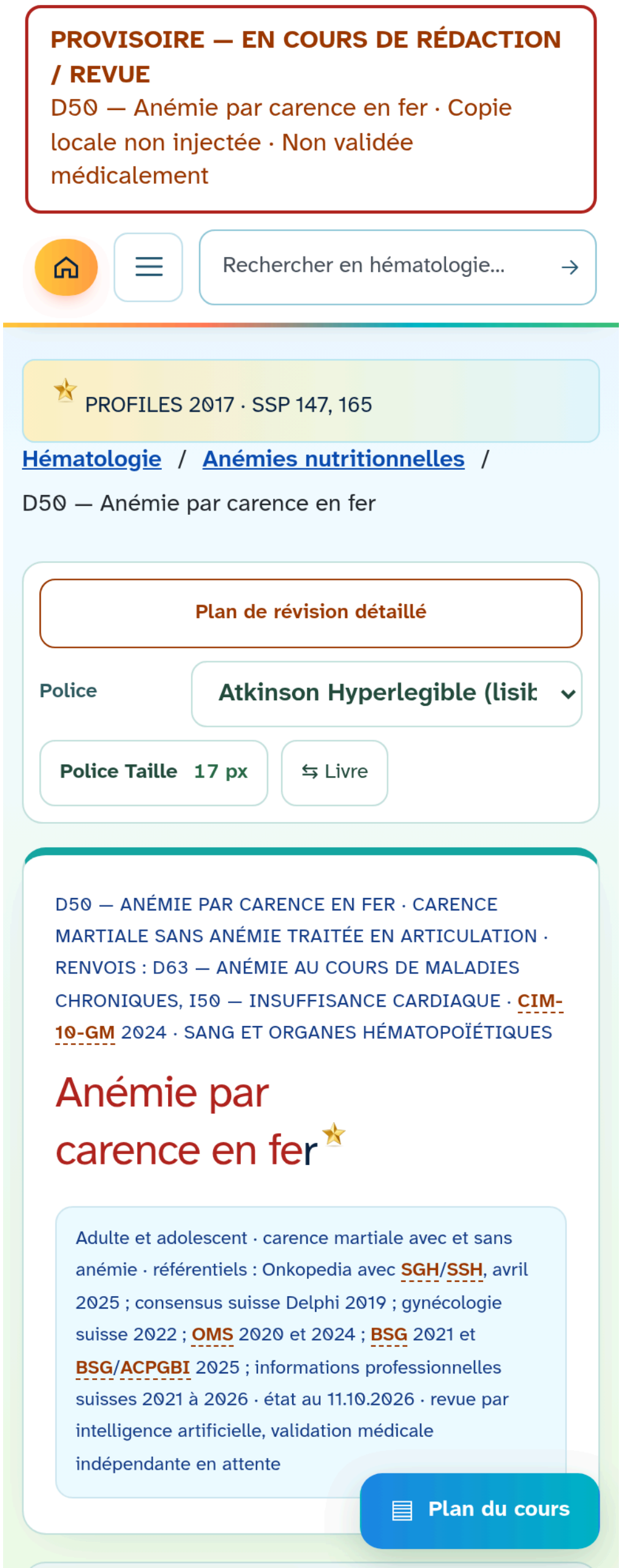
Chaque jour, l'homme perd environ 1 mg de fer par la desquamation intestinale, la femme réglée environ 2 mg. L'entérocyte duodénal absorbe 5 à 15 % du fer ingéré grâce au transporteur apical DMT1, le stocke temporairement dans sa ferritine, puis l'exporte vers le plasma par la ferroportine basolatérale. La transferrine le transporte vers la moelle, qui l'incorpore à l'hémoglobine, et vers le foie, qui le stocke. Les macrophages récupèrent le fer des hématies et le transfèrent aux érythroblastes par la même ferroportine.

Régulation par l'hepcidine

Plan du cours

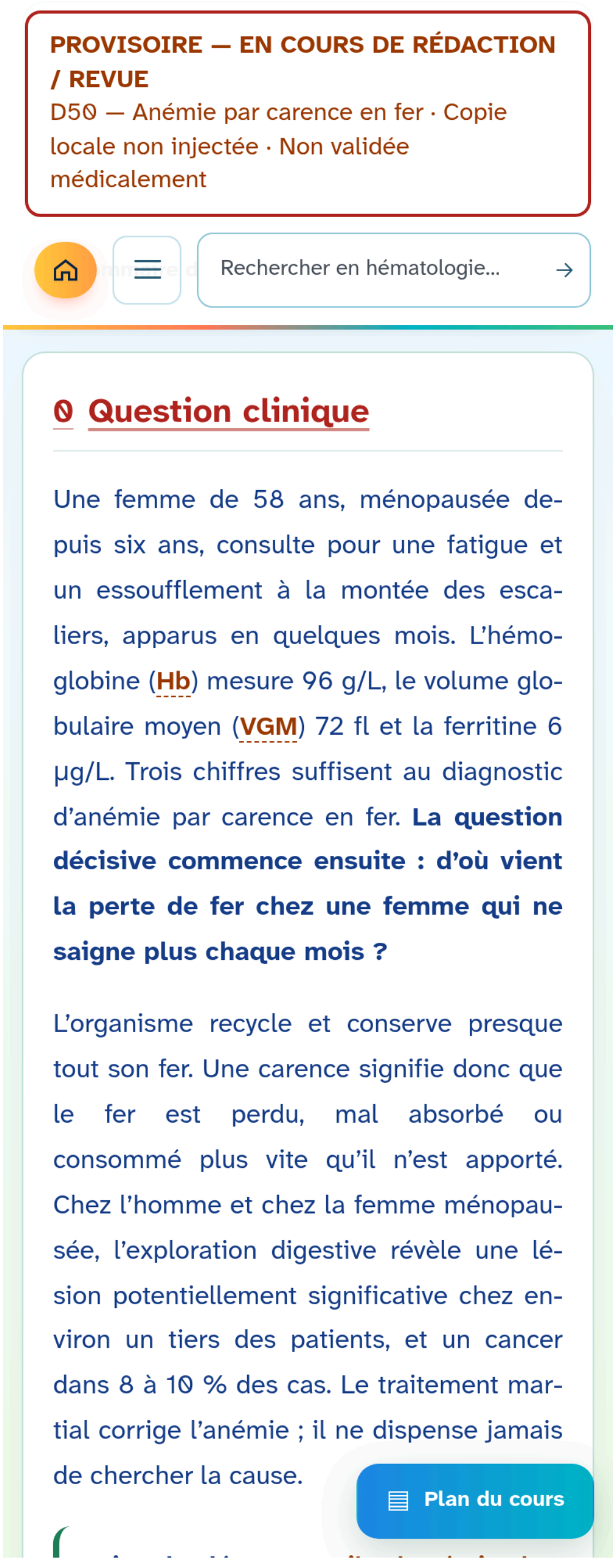
D50 — Anémie par carence en fer

11.10.2026 à 19:55:08 UTC+02:00 · Europe/Zurich



D50 — Anémie par carence en fer

11.10.2026 à 19:55:08 UTC+02:00 · Europe/Zurich



PROVENANCE ET LIMITES

Ce que montre ce dossier

Les captures du plan proviennent du site public de MEDINA. L'accueil photographié est une copie de préparation technique locale. Les quatre cours proviennent de copies figées des dossiers des rédacteurs, construites dans un espace isolé pour la photographie.

Le photographe n'a effectué aucune rédaction, aucun audit clinique, aucune injection, aucun commit ni aucune publication. Le bandeau rouge de consultation est ajouté uniquement aux aperçus locaux ; il ne modifie aucun texte médical.

Les captures documentent un rendu et des clics réels. Elles ne constituent pas une preuve de complétude du chapitre, de conformité aux sources, de réussite des audits ni de validation par un médecin.

Chapitre	Copie photographiée · Europe/Zurich	État
I63 — Infarctus cérébral	11.10.2026 à 19:53:27 UTC+02:00 · Europe/Zurich	Provisoire · non injecté
E11 — Diabète sucré, type 2	11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich	Provisoire · non injecté
N17 — Insuffisance rénale aiguë	11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich	Provisoire · non injecté
D50 — Anémie par carence en fer	11.10.2026 à 19:49:23 UTC+02:00 · Europe/Zurich	Provisoire · non injecté

Les fichiers **manifest.json** et **source-snapshots.json** conservent les dates, URLs, surfaces et empreintes des images et des sources. Les PNG originaux gardent leur résolution.

Ouvrir le plan public de la tétrade · Le cycle 2 reste soumis aux conditions de clôture.